

HERNIA DE HIATO

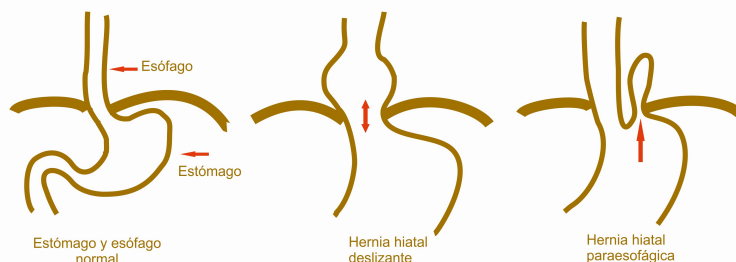
Haydée Calvo García, Tomás Elosua González, Julio Tito Camino Acha.

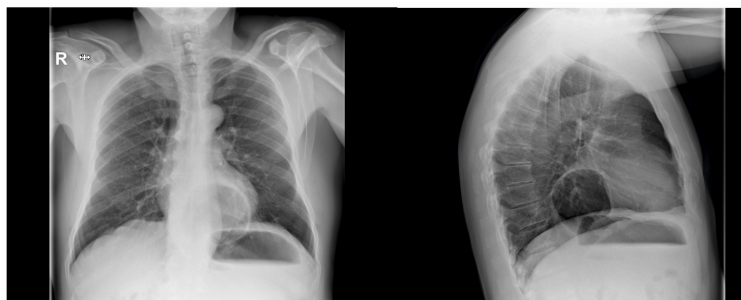
INTRODUCCIÓN

La hernia de hiato se refiere a la herniación hacia el tórax de elementos de la cavidad abdominal a través del hiato esofágico del diafragma. Es un hallazgo frecuente en pruebas de imagen y digestivas, más incidental que como diagnóstico en sí mismo, aunque tiene implicaciones clínicas. Como factores predisponentes se encuentran el aumento de la presión intrabdominal (obesidad, maniobras de Valsalva...) y la debilidad/ laxitud muscular de la membrana frenoesofágica y de los ligamentos que previenen el desplazamiento del estómago.

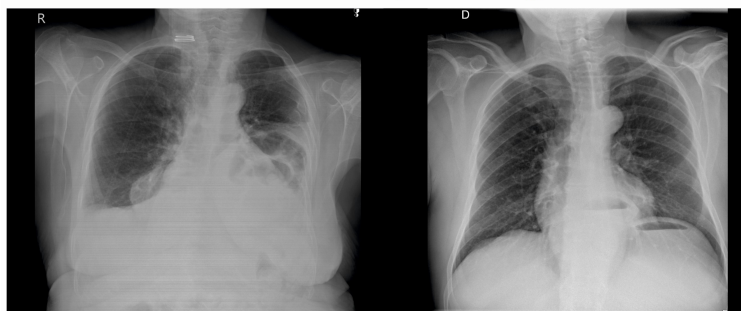
Clasificación

- **Tipo I:** por deslizamiento (95%). Desplazamiento de la unión esofagogástrica (UEG) por encima del diafragma, permaneciendo el estómago en su alineación longitudinal normal y el fundus por debajo de la UEG. No tienen saco herniario, la membrana frenoesofágica permanece intacta y se deslizan dentro del tórax conteniéndose en mediastino posterior.
- **Tipo II, III, IV:** paraesofágicas (5%). Verdadera hernia con saco herniario caracterizada por una dislocación hacia arriba del fundus gástrico a través de un defecto en la membrana frenoesofágica.
 - **Tipo II:** el fundus gástrico es el punto de herniación, mientras que la UEG permanece fija a la fascia preaórtica y al ligamento arcuato medio.
 - **Tipo III o mixtas (90%):** combinan elementos de los tipos I y II, ya que tanto la UEG como el fundus gástrico se hernian a través del hiato, permaneciendo el fundus por encima de la UEG.
 - **Tipo IV:** gran defecto en la membrana frenoesofágica caracterizado por la presencia de otros órganos además del estómago en el saco herniario (colon, bazo, páncreas, intestino delgado).





Hernia de hiato paraesofágica



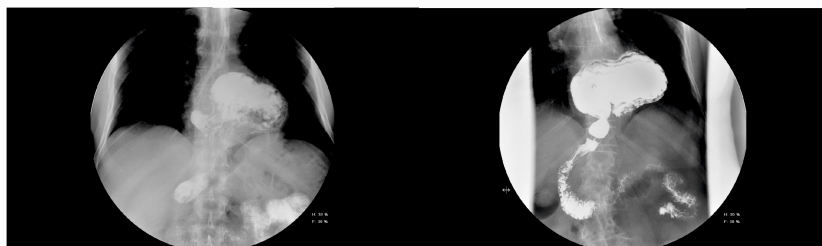
Hernia de hiato por deslizamiento y paraesofágica

- **Hernias por deslizamiento (tipo I):** se producen por la ruptura progresiva de la UEG, debido a traumatismos, malformaciones congénitas o factores yatrogénicos. El ensanchamiento del túnel muscular del hiato y la laxitud circunferencial de la membrana freno esofágica permiten que una porción del cardias gástrico se hernie hacia arriba.
 - **Mecanismo de reflujo gastroesofágico (RGE) en las hernias por deslizamiento:** El 50-94% de los pacientes con **enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)** tienen una hernia de hiato tipo I comparado con el 13-59% de individuos sanos. La probabilidad de RGE sintomático aumenta con el tamaño de la hernia. Pueden afectar:
 - **Competencia de la unión esofagogástrica:** La hipótesis del “doble esfínter” sugiere que tanto el esfínter esofágico inferior (EEI) como la crura diafragmática sirven de función esfinteriana cuando aumenta la presión intrabdominal, previniendo el reflujo. La hernia de hiato por deslizamiento disminuye la presión del EEI por sí sola y está asociada con una reducción del umbral para provocar relajaciones transitorias del EEI en respuesta a la distensión gástrica. Además, la complianza de la UEG durante la relajación esfinteriana está aumentada en pacientes con hernia de hiato y ERGE.
 - **Compromiso del vaciamiento esofágico:** Los pacientes con hernia de hiato por deslizamiento tienen prolongado el aclaramiento ácido especialmente en decúbito, ya que la hernia compromete el vaciamiento de fluidos desde el esófago distal por “re-reflujo” durante la deglución, proceso atribuido a la pérdida de la función normal de válvula unidireccional de la crura diafragmática, que ocurre durante la inspiración.
- **Hernias paraesofágicas:** son en su mayoría una complicación de la disección quirúrgica del hiato durante intervenciones antirreflujo, esofagomiotomías o gastrectomías parciales. Están asociadas a una laxitud anormal de los ligamentos gastroesplénico y gastrocólico, que previenen el desplazamiento del estómago. A medida que la hernia aumenta de tamaño, la curvatura mayor del estómago se enrolla en el tórax; la UEG está fija y el estómago herniado tiende a rotar sobre su eje longitudinal o menos frecuentemente sobre el eje transversal, resultando en un vólvulo organoaxial o mesenteroaxial respectivamente. Con el tiempo, puede herniarse el estómago al completo, con el píloro yuxtapuesto al cardias gástrico, y formar un

estómago intratorácico invertido.



Tránsito. Hernia por deslizamiento y esófago dilatado



Tránsito. Hernia paraesofágica y estómago volvulado

Clínica

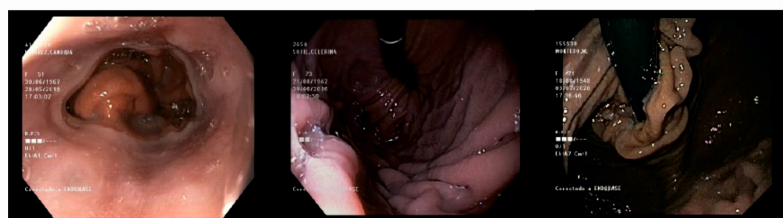
La mayoría de hernias de hiato por deslizamiento son asintomáticas. Los pacientes con hernias grandes pueden tener síntomas como dispepsia, ardor, dolor epigástrico, pirosis, regurgitación y disfagia. Las complicaciones son raras y suelen deberse a ERGE.

Los pacientes con hernias paraesofágicas son asintomáticos o tienen síntomas intermitentes, como dolor epigástrico o retroesternal, plenitud postprandial, náuseas y vómitos. Los síntomas derivados del reflujo son menos prevalentes que en pacientes con hernias por deslizamiento.

Complicaciones

Las complicaciones en las hernias paraesofágicas son infrecuentes pero pueden presentar alto riesgo de vólvulos y encarcelación que se incrementa con la edad. La mayoría de complicaciones se deben a problemas mecánicos causados por la propia hernia:

- **Vólvulo gástrico:** se manifiesta de forma aguda con la triada de Borchardt (dolor epigástrico intenso, náuseas improductivas e incapacidad para pasar una sonda nasogástrica). Puede producir disfagia y obstrucción, evolucionando rápidamente a necrosis; el dolor postprandial está relacionado con la distensión gástrica.
- **Hemorragia digestiva objetivada o anemia ferropénica:** aunque infrecuente, se produce por ulceración, gastritis o erosiones en la porción gástrica de la hernia encarcelada.
- **Isquemia esplácnica:** es resultado del compromiso vascular de los órganos herniados.
- **Complicaciones respiratorias o cardiológicas:** son resultado de la compresión mecánica de pulmón y corazón por una gran hernia.



Hernia por deslizamiento

Hernia paraesofágica



TC hernia paraesofágica

Tránsito. Hernia por deslizamiento + reflujo

DIAGNÓSTICO

La hernia de hiato no es un diagnóstico perseguido en sí mismo, sino un hallazgo casual en gastroscopias, manometrías u otras pruebas de imagen para diagnósticos de exclusión o realizadas como preoperatorio en pacientes con ERGE.

Las hernias paraesofágicas pueden diagnosticarse por gastroscopia, pero el contraste baritado es la prueba más sensible; una radiografía tórax en bipedestación, TC o RM torácicas pueden revelar una burbuja aérea gástrica, un nivel retrocardíaco, estómago intratorácico u otros órganos en el saco herniario.

Las hernias por deslizamiento mayores de 2 cm en el plano axial pueden diagnosticarse por contraste baritado, endoscopia o manometría esofágica. Sin embargo, si son pequeñas sólo pueden diagnosticarse con certeza intraoperatoriamente.

Pruebas complementarias

Según la clínica que presente nos plantearemos solicitar lo siguiente.

- Hemograma.
- Coagulación básica.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, amilasa, ProBNP, troponina US, CK. PCR.
- Gasometría arterial. Si $\text{SatO}_2 < 94\%$
- ECG con doce derivaciones.
- Radiografía tórax anteroposterior y lateral. Se observa masa retrocardíaca con nivel hidroaéreo. Generalmente la hernia se ubica a la izquierda de la columna vertebral, pero las de gran tamaño (hernias encarceradas) pueden extenderse más allá de la silueta cardíaca.
- Ecografía abdominal. Útil para descartar otras causas y para medir la unión gastroesofágica (en un corte transversal a nivel del hiato diafragmático tiene un diámetro normal 7.1 a 10mm), en una hernia no se puede demarcar.
- TAC Toraco-abdominal. Se aprecia una masa retrocardíaca con o sin nivel hidroaéreo, es útil para ver la anatomía del estómago intratorácico y para descartar volvulación.
- Gastroscopia según clínica del paciente, se puede solicitar urgente o programada.
- Esófagograma con contraste baritado: prueba de elección se realizará programada.

Diagnóstico diferencial

- Esofagitis
- Alteración de la motilidad esofágica
- Dispepsia funcional
- Enfermedad coronaria / IAM.
- Gastritis
- Infección por Helicobacter Pylori

TRATAMIENTO

- **Modificación de dieta y estilo de vida:** pérdida de peso, cabecero elevado, evitar acostarse justo después de comer/ cenar, evitar determinados alimentos (cafeína, chocolate, picante, grasas, bebidas azucaradas, alcohol, tabaco...)
- **Síntomas leves y/o infrecuentes:** medidas higiénico-dietéticas + antiácidos (Almax)/ antagonistas H2 (Famotidina).
- **Síntomas graves y/o frecuentes:** medidas higiénico-dietéticas + inhibidores de la bomba de protones (Omeprazol) durante 8 semanas.
- No está indicada la reparación quirúrgica de una hernia aislada y asintomática. El manejo de los pacientes con hernias sintomáticas consiste en el tratamiento de la ERGE, por lo que se remitirán a Consultas Externas de Digestivo, sin necesidad de atención urgente en ese momento.
- **Tratamiento quirúrgico electivo.** Está indicado en pacientes sintomáticos refractarios al tratamiento médico. Requieren cirugía urgente los pacientes complicados con perforación, hemorragia no controlada con tratamiento endoscópico o inestabilidad hemodinámica, o con vólvulo gástrico, obstrucción, estrangulación y compromiso respiratorio secundario que no responden a descompresión endoscópica, por lo que se solicitará Interconsulta al Servicio de Cirugía sólo en esos casos.

BIBLIOGRAFÍA

- Kahrilas PJ, Talley NJ, Grover S. Hiatus hernia. Pathophysiology of reflux esophagitis. Medical management of gastroesophageal reflux disease in adults. Uptodate. Nov-Dec 2020.
- Rosen M, Blatnik J, Marks J, Louie BE, Chen W. Surgical management of paraesophageal hernia. Uptodate. Dec 2020.
- Ortiz A, Martínez L, Parrilla P. Cirugía esofagogástrica (2ª edición). Guías Clínicas de la Asociación Española de Cirujanos. 2017.
- Madriz Meza W, Alvarado Rodríguez V.H, Jaén Hernández J. Diagnóstico Radiológico de Hernia Hiatal. Revista Medica de Costa Rica y Centroamerica. LXV (583) 103-108; 2008.